



FEMEIA SI ANGIOEDEMUL EREDITAR (AEE)

CUPRINS

Femeia și AEE.....	1
AEE și corpul feminin	3
Copilărie și pubertate: copilul de sex feminin și AEE	4
Întrebări frecvente: Din perspectiva unui copil sau a unui adolescent	6
Întrebări frecvente: Din perspectiva părintelui sau a unei femei adulte	8
Sarcina și planificarea familială la femeia cu AEE.....	11
Întrebări frecvente: Din perspectiva femeii gravide.....	14
Resurse pentru planificarea familială și sarcină.....	18
Întrebări frecvente: menopauza și îmbătrânirea	21

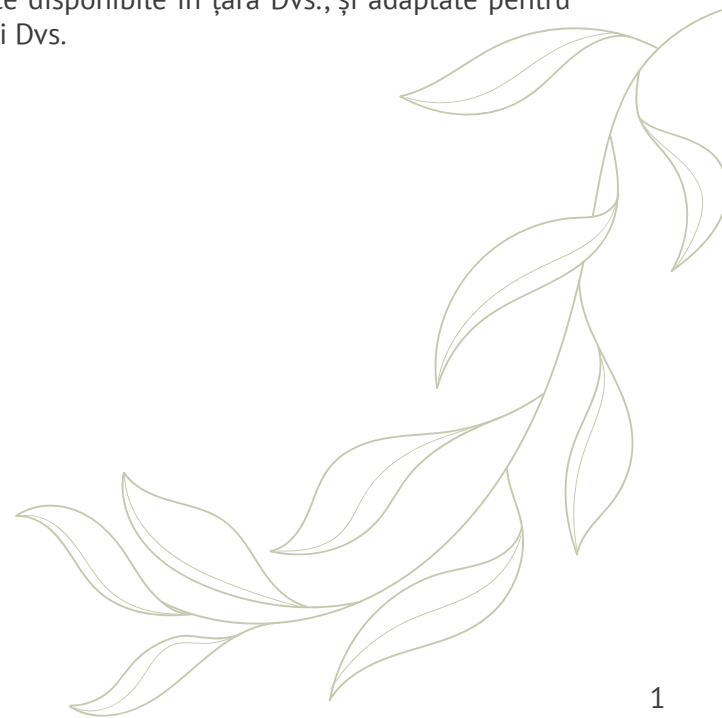
FEMEIA ȘI AEE

Scopul acestui **Ghid pentru femeile cu angioedem ereditar (AEE)** este de a oferi informații cu privire la provocările unice cu care se confruntă femeia cu AEE.

Studiile arată că simptomele AEE sunt mai severe la femei decât la bărbați. Acest ghid este creat pentru a ajuta femeile cu AEE să treacă mai ușor prin cele trei etape specifice ale vieții:

- 1) copilăria și pubertatea.
- 2) planificarea familială și sarcina.
- 3) menopauza și îmbătrânirea.

Acest ghid a fost scris pentru un public internațional. Ca urmare, fiind o mare variație a tratamentelor disponibile în diferite țări, este necesar să consultați întotdeauna medicul Dvs. curant pentru opțiunile terapeutice disponibile în țara Dvs., și adaptate pentru fiecare etapă a vieții Dvs.





AEE ȘI CORPUL FEMININ

Înțelegerea bolii și efectului acestuia asupra corpului feminin

De la debutul pubertății și până la etapele târzii ale menopauzei, femeile se confruntă cu fluctuații hormonale considerabile, în special în ceea ce privește estrogenul. Modificările nivelului de estrogeni pot afecta frecvența și severitatea atacurilor de AEE. Pe măsură ce femeile trec prin diferitele etape ale vieții, este important să fie atenți la modul în care variațiile hormonale pot afecta simptomele de AEE și la abordarea potrivită cu privire la tratamentul atacurilor.

Testarea (diagnosticul) pentru AEE

Testarea precoce este esențială pentru a confirma diagnosticul de AEE. Pentru un diagnostic de certitudine privind AEE de tip I și de tip II sunt necesare efectuarea unor teste din sânge.

Aceste teste pot fi recomandate de un medic expert în AEE sau de orice medic care ridică suspiciunea acestei afecțiuni, cu variații în diferite țări.

Analizele de sânge necesare pentru diagnosticul de AEE sunt:

- Nivelul seric de C4.
- Nivelul seric de C1 -inhibitor esterază dozare proteică și
- determinare de C1 -inhibitor esterază - activitate/funcție.

AEE cu valori normale de C1-inhibitor esterază

Unele persoane au diagnostic de AEE, dar au teste de sânge cu niveluri normale de C1-inhibitor esterază. Este important să discutați acest diagnostic cu medicul dumneavoastră.



De la copilărie până la pubertate:

COPILĂRIA ȘI AEE

Dacă sunteți părintele și/sau îngrijitorul unui copil cu AEE, este important să fiți pregătit în momentul în care copilul dumneavoastră începe să aibă simptome. Obținerea unui diagnostic precoce este esențială pentru a vă asigura că atât dumneavoastră, cât și pediaterul și medicul care tratează AEE să aveți un plan de acțiune pentru tratamentul atacului de AEE.

Elaborarea unui plan de tratament

Deși mulți copii nu încep să prezinte simptome de AEE până la pubertatea timpurie, este important să colaborați cu medicul dumneavoastră pentru a dezvolta un plan de tratament, astfel încât familia dumneavoastră să se simtă în siguranță și pregătită în cazul apariției unui atac de AEE.

Planul de tratament ar trebui să includă următoarele, în funcție de cum sunt disponibile în țara dvs.:

- O prescripție medicală și un medicament specific pentru AEE care să fie disponibil atunci când este necesar.
- O scrisoare medicală cu diagnosticul de AEE și recomandările de tratament, pe care să o arătați, la nevoie, personalului de la Serviciul de Urgență.
- Un plan coordonat pentru a face față unui atac dacă acesta apare când copilul este la școală.

Copiii mici și cei cu atacuri rare, adesea nu pot identifica/recunoaște atacul de AEE. Este important să discutați cu copilul dumneavoastră la ce să se aștepte în cazul unui atac de AEE.

Vârsta de apariție a simptomelor variază considerabil de la persoană la persoană. Totuși, studiile arată că jumătate dintre pacienți au raportat debutul simptomelor până la vârsta de zece ani, iar majoritatea oamenilor au experimentat primul atac înainte de vârsta de 18 ani. De asemenea, pare să existe o frecvență crescută a atacurilor în timpul pubertății sau adolescenței și

odată cu apariția menstruației (datorită modificărilor nivelului de estrogeni).

Sprijin

În calitate de părinte și/sau îngrijitor, veți fi cel mai bun sprijin al copilului dumneavoastră. Prin urmare, este important să (1) înțelegeți modul în care AEE poate afecta viața copilului dvs. și (2) să puteți vorbi în cunoștință de cauză în numele copilului dumneavoastră. Pentru mai multe informații despre diferitele tipuri de angioedem, simptome, factorii declanșatori și tratamentele curente, vă rugăm să vizitați site-ul HAEi la haei.org.

Creați un plan de tratament

Părinții și/sau îngrijitorii ar trebui să colaboreze cu medicul curant al copilului lor pentru a crea un plan de gestionare a atacurilor de AEE, inclusiv modalitățile de tratament (unde este disponibil).

Stabiliți un plan de urgență

Este important ca toți cei implicați în îngrijirea copilului dumneavoastră să cunoască planul de îngrijire pentru o situație de urgență legată de AEE. Pregătiți și furnizați informații detaliate cu tot ceea ce este necesar pentru a avea grijă de copilul dumneavoastră într-o situație de urgență, inclusiv tratamentul folosit de copilul dumneavoastră, dorințele dumneavoastră despre cum și unde copilul dumneavoastră ar trebui să primească tratament și cele mai bune informații de contact.

HAEi a dezvoltat carduri de urgență care conțin informații clare și directe despre AEE și tratamentul necesar în timpul unui atac. Cardurile de urgență sunt traduse în multe limbi și sunt disponibile prin aplicația noastră HAE Companion și pe site-ul web HAEi la haei.org.

Dacă călătoriți cu copilul dumneavoastră, asigurați-vă că știți unde se află cea mai apropiată unitate medicală de urgență. Folosind aplicația HAEi, HAE Companion, puteți găsi întotdeauna cel mai apropiat medic sau spital cu cunoștințe în HAE.

Întrebări frecvente la care au răspuns medicii noștri experți în HAE:

DIN PERSPECTIVA UNUI COPIL SAU A UNUI ADOLESCENT

Cu ce adulți ar fi nevoie să vorbesc despre AEE?

Este important să vorbești despre AEE cu adulții din viața Dvs. Ei sunt în măsură să vă sprijine dacă aveți un atac și aveți nevoie de ajutor. Acești adulți pot fi profesorii, asistentele, antrenorii și consilierii școlii dumneavoastră. Alți adulți cu care este bine să vorbești ar putea fi părinții prietenilor Dumneavoastră, adulții de la programele extrașcolare și oricine cu care aveți contact regulat. A vorbi cu ei despre boala dumneavoastră îi ajută să fie pregătiți să vă sprijine în cazul unui atac de AEE.

Care sunt unele sfaturi pentru a mă ajuta la monitorizarea bolii mele, astfel încât să pot urmări atacurile și factorii declanșatori?

Urmărirea/notarea momentului în care apare un atac, localizarea acestuia și posibili factori declanșatori vă pot ajuta să înțelegeți mai bine boala Dvs. Puteți ține un jurnal sau puteți utiliza jurnalul electronic gratuit și ușor de utilizat al HAEi, aplicația HAE TrackR, pentru a vă monitoriza și documenta atacurile. De asemenea, puteți ține un jurnal al ciclurilor menstruale și puteți vedea dacă acestea se corelează cu atacurile/cu starea de rău a Dvs. Împărtășiți aceste informații medicului dumneavoastră curant de AEE la vizita următoare, deoarece poate fi foarte importantă.

Cum pot afecta pubertatea și menstruația simptomele de AEE și la ce să mă aștept în această perioadă?

Hormonii pot juca un rol în apariția simptomelor și severitatea AEE. Pubertatea provoacă adesea creșterea (sau apariția) simptomelor de AEE. Pubertatea vine cu multe schimbări. Este important să acceptăm schimbările și provocările din timpul tranziției la maturitate. Menstruația poate duce la atacuri mai frecvente și mai severe la femei. Dacă acest lucru devine supărător și vă afectează foarte mult calitatea vieții, discutați cu medicul dumneavoastră curant.



Apare frecvent atacul genital?

Localizarea umflăturilor poate fi diferită pentru fiecare persoană. La unii nu apar atacuri genitale, în timp ce alții se confruntă frecvent cu această localizare. Atacul genital poate fi primul semn de AEE pentru unele persoane. Acesta poate fi localizat la nivelul scrotului pentru băieți și la nivel labial pentru fete. Adesea această localizare se datorează unui traumatism/presiune locală (ex. mersul pe bicicletă), dar poate apărea și fără un factor declanșator cunoscut.

Cum pot explica AEE prietenilor mei?

Unii pacienți cu AEE spun că au sânge special. Educarea prietenilor tăi îi va face să înțeleagă afecțiunea ta și asta te va ajuta.

Cum ar trebui să gestionez AEE și activitățile extrașcolare/fizice?

Fiți activ și trăiți-vă viața la maxim! Discutați cu medicul dumneavoastră despre elaborarea unui plan pentru a vă maximiza activitățile în siguranță și progresiv. Abordare unui stil de viață activ și sănătos vă poate ajuta la menținerea unei stări generale de bine, atât mentală cât și fizică.

Întrebări frecvente la care au răspuns medicii noștri experți în AEE:

DIN PERSPECTIVA PĂRINTELUI SAU A FEMEII ADULTE

Cum ar trebui să arate un plan de urgență pentru copilul meu? Ce ar trebui să pregătesc în avans cu medicul copilului meu?

Asigurați-vă că aveți fișa medicală care include diagnosticul, rezultatele analizelor de sânge și informațiile de contact ale specialistului de AEE al copilului Dvs: tipărite și/sau stocate pe un stick USB sau de memorie. Să aveți un număr de telefon pentru specialistul de AEE al copilului Dvs, astfel încât, la nevoie acesta să

poată vorbi cu personalul de la serviciul de urgență sau la nevoie cu alt departament în cazul în care copilul Dvs a fost dus la o unitate medicală unde nu se cunoaște această afecțiune. Asigurați-vă, prin vizite periodice la medicul curant de AEE că copilul Dvs primește cea mai adecvată terapie, luând în considerare orice aprobare/disponibilitate nouă de tratament în țara Dvs.

AEE și contracepția - ce trebuie să știu? Ce opțiuni de contracepție sunt pentru pacientele cu AEE?

Discutați cu medicul Dvs despre metoda de contracepție pe care intenționați să o utilizați. Pentru multe paciente, hormonii pe bază de estrogen pot crește frecvența și severitatea atacurilor de AEE.

Există o legătură între infecțiile tractului urinar și atacurile de AEE?

Ca și în cazul oricărei infecții sau inflamații, acestea pot declanșa atacuri de AEE.

Cum îmi pot întreba medicul despre posibilitatea unui nou tratament pentru AEE?

Discutați despre terapiile noi aprobate și vedeți dacă planul Dvs. actual de tratament funcționează (este eficient) pentru Dvs. Acesta este motivul pentru care vizitele regulate la medicul Dvs curant pot fi de ajutor, chiar vă pot schimba viața. Comunicarea deschisă și frecventă între Dvs și medicul Dvs este la fel de important ca întotdeauna. Amintiți-vă că atacurile și factorii declanșatori ai atacurilor se pot schimba de la o lună la alta sau de la an la an.

Aveți vreun sfat de gestionare a stresului?

Introduceți natura și mijloacele naturale pentru gestionare stresului. Aceasta poate include orice, de la o excursie la o plimbare pe malul apei (râu/ocean) sau activități cu impact redus, cum ar fi meditația, muzica și alte metode care promovează relaxarea profundă.





SARCINA ȘI PLANIFICAREA FAMILIALĂ CU AEE

Planificarea unei familii și perioada de sarcină este un interval special în viață. AEE nu afectează fertilitatea, dar pentru femeile cu AEE, este important să se înțeleagă modul în care afecțiunea le-ar putea afecta perioada de sarcină. Elaborarea unui plan și colaborarea cu medicul obstetrician/ginecolog și medicul curant de AEE va stabili baza pentru o sarcină mai sănătoasă și mai fericită.

La fel ca și simptomele de AEE, și experiența din timpul sarcinii poate fi diferită de la o sarcină la alta.

Comunicarea este cheia

Discutați cu medicul Dvs curant pentru AEE, precum și cu obstetricianul/ginecologul, despre stabilirea unui plan de tratament pentru perioada de sarcină. Asigurați o comunicare continuă și deschisă între medicul Dvs curant de AEE și obstetricianul/ginecologul.

Implicații genetice

AEE este o afecțiune ereditară (moștenită), iar fiecare copil născut dintr-un părinte cu AEE are o șansă de 50% de a moșteni boala. Dacă doriți să rămâneți gravidă sau sunteți însărcinată, medicul Dvs curant vă va urmări îndeaproape pentru a discuta cu Dvs despre managementul adecvat al AEE pe perioada de sarcină.

Terapiile de fertilitate

Cuplurile care se luptă cu concepția, ar putea lua în considerare opțiunile de tratament pentru fertilitate. Fluctuațiile legate de tratamentul cu hormonul feminin - estrogen, pot influența simptomele de AEE. Este important ca femeile care aleg să urmeze tratamente de fertilitate să discute dacă sunt necesare modificări ale planului lor actual de tratament pentru AEE.

Pe perioada sarcinii

La fel ca boala în sine, nu există două sarcini identice, iar atacurile de AEE pot varia ca frecvență și/sau severitate în timpul sarcinii. Medicul Dvs curant de AEE vă poate ajuta să dezvoltați un plan de tratament specific nevoilor Dvs pe perioada sarcinii, în timpul și după naștere, precum și pe perioada alăptării.

Conform recomandărilor ghidului internațional de tratament (2021) terapia cu androgenii anabolizanți (sau steroizi) nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării. Acidul tranexamic poate fi luat în considerare în această perioadă, iar C1-INH derivat din plasmă este recomandat ca terapie de primă linie pentru pacientele cu HAE-1/2 gravide sau care alăptează. Atunci când C1-INH nu este disponibil, plasma tratată cu solvent cu detergent (SDP) poate fi utilizată iar în cazul indisponibilității acestuia, se va administra plasma proaspătă congelată. Pentru alte medicamente, la momentul publicării ghidurilor, nu sunt date publicate pentru utilizarea lor în sarcină și perioada de alăptare.

Fiți pregătiți pentru simptomele de AEE

Dacă la unele femei nu apar atacuri de AEE în timpul sarcinii, altele raportează o frecvență și/sau severitate crescută a atacurilor în timpul acesteia. Este important să acordați atenție semnelor precoce ale simptomelor de AEE, astfel încât să puteți administra rapid tratamentul de urgență și să limitați severitatea unui atac de îndată ce acesta este recunoscută. Amintiți-vă că tratamentul cu steroizi anabolizanți (cunoscuți și ca androgeni) nu este recomandat în timpul sarcinii.

Asigurați-vă de disponibilitatea medicamentelor necesare

Dacă aveți un tratament de urgență pentru atacul de AEE care este recomandat pentru utilizare în timpul sarcinii, asigurați-vă că acesta este disponibil la spitalul în care intenționați să decurgă nașterea. De asemenea, ar trebui să asigurați orice tratament suplimentar de care aveți nevoie (acut și profilactic) după nașterea copilului și apoi când sunteți externată.



Considerații pentru perioada post-partum

- Păstrați medicamentele la îndemână
Atacurile de AEE sunt rare în timpul nașterii, dar există unele indicii că o creștere a frecvenței și a severității atacurilor este posibilă după acesta. Asigurați-vă că aveți doze suficiente de medicație pentru săptămânile și lunile următoare nașterii, perioadă în care corpul Dvs suferă modificări hormonale.
- Alăptarea
Alăptarea poate fi asociată cu un număr crescut de atacuri la mamă, dar acesta este recomandat datorită beneficiilor oferite sugarului. Există tratamente eficiente pentru AEE care pot fi utilizate în siguranță în timpul alăptării. Androgenii nu trebuie utilizați în timpul alăptării. Dacă vă gândiți să vă alăptați copilul, discutați cu medicul Dvs despre opțiunile disponibile potrivite pentru această perioadă.
- Testarea copilului DVs pentru AEE
Deși este posibil să fiți nerăbdătoare să aflați dacă copilul Dvs are și el AEE, se recomandă, în general, să așteptați până la împlinirea vârstei de un (1) an pentru a-l testa și pentru a asigura un rezultat mai precis al testului.

Întrebări frecvente la care au răspuns medicii noștri experți în AEE:

DIN PERSPECTIVA UNEI FEMEI ÎNSĂRCINATE

Ce medicamente pot folosi pentru a-mi trata AEE în timpul sarcinii?

Deși nu au existat studii clinice care să testeze siguranța medicamentelor specifice pentru AEE la femeile însărcinate și copiii lor, există o serie de date de la femei însărcinate din SUA și Europa care au folosit, în timpul sarcinii, terapii de substituție cu C1-INH derivat din plasmă. Ghidurile internaționale recomandă acest produs (C1INH derivat din plasmă) ca terapie preferată în timpul sarcinii și alăptării. Cu toate acestea, acest lucru nu este disponibil în toate țările. Consultați pagina anterioară pentru mai multe informații din ghid. Ar trebui să discutați cu medicul Dvs de AEE pentru a stabili care terapie ar fi cea mai potrivită pentru dvs.

Medicamentele de evitat în mod specific în timpul sarcinii includ toate formele de androgeni, care sunt rude ale hormonului masculin, testosteron. Aceste medicamente pot afecta dezvoltarea fetală și ar trebui evitate dacă intenționați să aveți un copil și trebuie întrerupte imediat dacă descoperiți că sunteți însărcinată.

Având AEE clasifică sarcina mea drept „risc ridicat”?

De obicei, obstetricianul și/sau ginecologul și echipa lor sunt cei care decid dacă o sarcină este sau nu considerată cu risc/risc ridicat. Obstetricienii și/sau ginecologii, totuși, vor clasifica adesea pacientele cu AEE drept „risc ridicat”, din cauza considerațiilor suplimentare care trebuie abordate în timpul sarcinii. Nu trebuie însă să vă îngrijorați!. Acesta înseamnă doar că profesioniștii din domeniul sănătății acordă o atenție deosebită Dvs și copilului Dvs pentru a asigura o naștere fără complicații.

Ce se întâmplă dacă este nevoie de o cezariană neașteptată?

Ghidurile internaționale recomandă, unde este disponibilă, utilizarea unei injecții intravenoase cu C1 inhibitor, înainte de o cezariană. Acest lucru este pentru a asigura ca nivelurile dvs. de C1 inhibitor esterase sunt suficient de ridicate pentru a vă proteja de apariția unui atac (umflătură). De asemenea, este important să aveți mai multe doze de medicamente la îndemână dacă apare un atac după intervenția chirurgicală. Această întrebare evidențiază, de asemenea, importanța de a discuta în prealabil planurile de tratament cu obstetricianul și/sau ginecologul și specialiștii de AEE, astfel încât să aveți încredere că toată lumea va fi pregătită.

Să fiu gravidă îmi va afecta simptomele de AEE?

Cercetările nu au arătat nicio modalitate de a prezice modul în care simptomele Dvs de AEE s-ar putea schimba în timpul sarcinii. Este posibil ca simptomele să se îmbunătățească, să se agraveze sau să rămână aceleași. Pot fi făcute ajustări ale medicamentelor utilizate dacă sarcina provoacă modificări ale simptomelor de AEE.

Genul copilului influențează severitatea AEE în timpul sarcinii?

Nu există dovezi care să sugereze că sexul copilului va afecta frecvența și severitatea simptomelor de AEE din timpul sarcinii.

Am avut deja un copil și sunt însărcinată cu al doilea. Mă pot aștepta ca simptomele mele de AEE să fie similare cu prima mea sarcină?

Confirm datelor din literatură fiecare experiență de sarcină este diferită. În timp ce cineva poate avea o schimbare mică sau deloc în frecvența atacurilor în timpul primei sarcini, pot exista variații importante în frecvența și severitatea simptomelor în timpul sarcinilor ulterioare.

Întrebări frecvente la care au răspuns medicii noștri experți în AEE:

La ce ar trebui să mă aștept și să mă pregătesc în timpul nașterii copilului meu?

Majoritatea femeilor raportează că totul merge destul de bine în timpul nașterii. După cum s-a menționat mai devreme, este important să aveți mai multe doze de medicamente la îndemână în cazul apariției unui atac. După naștere, este, de asemenea, important să fiți conștient de faptul că poate crește frecvența/severitatea atacurilor.

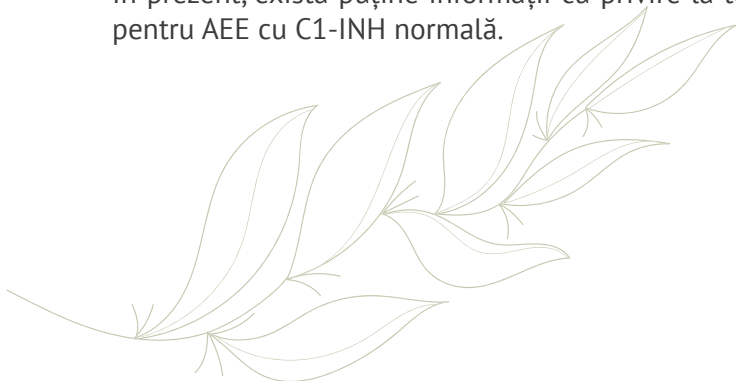
Care este șansa de a transmite AEE copilului meu?

Dacă oricare dintre părinți are AEE de tip I sau de tip II (deficiență de C1-inhibitor), există o șansă de 50% ca boala să fie transmisă copilului lor.

Oamenii de știință bănuiesc că modelul de moștenire pentru AEE cu valori normale de C1-inhibitor esterază este similar cu ceea ce se observă în AEE de Tip1 și 2 (du deficiență de C1-inhibitor esterază), dar cercetările sunt în desfășurare.

La ce vârstă este recomandat să testez copilul meu pentru AEE?

Se recomandă ca toți copii din familia Dumneavoastră să fie testați pentru AEE încă din primul an de viață. Este important să știți dacă copilul dumneavoastră are AEE, astfel încât să puteți fi pregătit în cazul unui atac. Pentru HAE-C1-INH (Tipul I și Tipul II), acesta implică teste de sânge simple și, de obicei, acestea pot fi recomandate/efectuate la cabinetul unui medic, măsurând nivelurile de C4, C1-Inhibitor cantitativ și C1-Inhibitor funcțional. În prezent, există puține informații cu privire la testarea copiilor pentru AEE cu C1-INH normală.



Cum pot vorbi despre AEE cu obstetricianul și/sau ginecologul meu?

Este important să stabiliți o cale de comunicare între medicul Dumneavoastră care tratează AEE și obstetricianul și/sau ginecologul. Procedând astfel, se va asigura că la întrebările Dvs veți primi răspuns corespunzător și că medicii colaborează pentru a crea un plan de tratament pentru dvs.

Planul dumneavoastră de tratament trebuie să:

- Asigure că toată lumea cunoaște procedurile de administrare a medicamentelor și că medicamentul este disponibil în orice moment,
- Să abordeze modul în care persoana cu AEE va accesa medicamentele în timp ce se află în îngrijirea spitalului (va fi adus cu ea sau va trebui să folosească farmacia din spital?) și
- Confirme că există un plan în cazul în care se efectuează o operație cezariană (puneți orice întrebare pe care le-ar putea avea medicul anestezist).

La ce să mă aștept după naștere?

Perioada de recuperare, indiferent că a fost naștere fiziologică sau prin cezariană, poate declanșa simptome de AEE, așa că este important să se trateze încă de la debut orice atac suspectat a fi legat de AEE. După cum am discutat, în timp ce nașterea fiziologică de obicei nu declanșează atac de AEE, post-partum la multe femei poate crește frecvența/intensitatea atacurilor.

Ar trebui să mă aștept la vreo schimbare în AE în timpul alăptării?

Acesta este un alt domeniu în care avem nevoie de mai multe informații. Deși nu este obișnuit, unele femei au indicat că au prezentat mai multe simptome de AEE în timpul alăptării. Vă rugăm să discutați despre tratamentul dumneavoastră cu medicul dumneavoastră de AEE, dacă decideți să alăptați. Dacă aveți terapii derivate din C1-INH, se recomandă să continuați cu acestea pentru a trata sau a preveni atacurile de AEE în timpul alăptării.

Resurse pentru:

PLANIFICAREA FAMILIALĂ ȘI SARCINA

Coordonare/îngrijire pentru femeia însărcinată cu AEE

Mai jos veți găsi sugestii de planificare pe parcursul sarcinii. Discutați cu obstetricianul și/sau ginecologul dumneavoastră despre a avea un tratament disponibil acolo unde urmează să nașteți.

Jurnalul meu de sarcină

Urmăriți-vă experiența din timpul sarcinii. Observați consumul de apă, frecvența atacurilor și orice modificări pe care le observați pe parcursul sarcinii și perioada post-partum.

Lista mea de verificare pe perioada sarcinii

- Informați medicul obstetrician și/sau ginecologul că aveți AEE.
- Stabiliți comunicare între membrii echipei de asistență medicală (medic curant AEE și obstetrician și/sau ginecolog).
- Colaborați cu echipa dvs. de asistență medicală pentru a crea un plan de tratament care să acopere toate aspectele sarcinii, inclusiv tratamentele de AEE pentru atacuri și orice simptome care eventual apar în timpul spitalizării.
- Utilizați jurnalul electronic gratuit și ușor de utilizat al HAEi, aplicația HAE TrackR, pentru a urmări simptomele dvs. de HAE.

Al doilea trimestru (pregătirea pentru naștere)

Obțineți o scrisoare de la medicul curant sau de la obstetricianul și/sau ginecologul dvs. care să cuprindă procedurile de tratament în cazul unei nașteri prin cezariană sau a altor proceduri necesare.

Al treilea trimestru

Să aveți o scrisoare medicală tipărită care cuprinde planul de tratament cu informațiile de contact atât ale obstetricianului și/sau ginecologului, cât și ale medicului curant de AEE.



Preluati controlul asupra AEE cu HAE TrackR

HAE TrackR este dezvoltat de colegii pacienți cu AEE de la HAEi și conceput pentru a înregistra atacurile, tratamentele și impactul pe care AEE îl are asupra vieții tale și a celor dragi. Aplicația poate fi utilizată pentru a lua decizii importante cu privire la cel mai bun mod de a vă gestiona AEE; de exemplu, puteți trimite medicului dumneavoastră un raport al atacurilor și tratamentelor dumneavoastră, dacă doriți.

HAE TrackR poate fi accesat de pe orice dispozitiv (smartphone, tabletă sau computer) oriunde în lume – vizitați haetrackr.org pentru a afla mai multe și pentru a începe să utilizați aplicația.



Întrebări frecvente la care au răspuns medicii noștri experți în AEE:

MENOPAUZA ȘI ÎMBĂTRÂNIREA

Menopauza are ca rezultat, de obicei, scăderea producției de estrogen, afectând semnificativ simptomele AEE la femei. Medicii prescriu adesea terapie de substituție cu estrogeni pentru femeile aflate la menopauză. Este important să discutați despre riscurile și beneficiile înlocuirii hormonale cu medicul dumneavoastră care tratează AEE.

Mă apropii de vârsta menopauzei. Cum ar putea acest lucru să îmi afecteze AEE?

Studiile care investighează efectul menopauzei asupra simptomelor de AEE au arătat rezultate mixte. Un studiu amplu publicat a arătat că după menopauză, simptomele AEE s-au îmbunătățit la 13% dintre femei, au rămas aceleași la 55% și s-au agravat la 32%. Un alt centru mare de AEE a raportat că după menopauză, la 50% dintre femei s-au îmbunătățit simptomele, dar la 15% acestea s-au agravat, în unele cazuri cu simptome severe. AEE este foarte variabilă și imprevizibilă în timpul menopauzei. Prin urmare, este important să urmăriți recomandările medicului dumneavoastră care tratează AEE pentru a vă asigura că planul dumneavoastră de tratament a AEE este cel mai bun posibil.

Pot folosi terapia de substituție hormonală în timpul menopauzei?

Se știe că medicamentele sistemice (orale sau injectabile) care conțin estrogen cresc simptomele de angioedem la majoritatea femeilor (până la 80%) cu AEE. Efectul medicamentelor topice care conțin estrogeni (plasturi sau loțiuni) asupra AEE nu a fost studiat în detaliu. Cu toate acestea, trebuie luată cu precauție extremă folosirea oricărui medicament care conține estrogen. În general, se recomandă evitarea tratamentelor cu estrogeni în timpul menopauzei, iar alte tratamente sau strategii fără estrogeni sunt încurajate pentru a trata simptomele menopauzei.

Întrebări frecvente la care au răspuns medicii noștri experți în AeE:

Pot să urmez terapie de substituție hormonală dacă urmez un tratament preventiv pentru AEE?

Răspunsul la această întrebare este necunoscut deoarece acest subiect nu a fost studiat în mod adecvat. Se știe că medicamentele care conțin estrogeni cresc frecvența atacurilor de AEE. Prin urmare, trebuie luată o precauție extremă la introducerea tratamentului cu estrogeni.

Ce pot face pentru a ajuta simptomele menopauzei dacă nu pot lua înlocuire cu estrogen?

Opțiunile de tratament pentru simptomele asociate menopauzei trebuie discutate cu atenție cu ginecologul sau cu medicul de familie și cu medicul care tratează AEE. După cum s-a menționat mai devreme, medicamentele cu estrogeni trebuie, în general, evitate. Datele despre estrogenii transdermici sau topici sunt mai puțin clare, cu câteva rapoarte despre aceste formulări fiind tolerate la unele femei cu AEE, dar simptomele agravându-se la altele. Deși anumite femei pot tolera tratamentul cu estrogeni transdermic sau topic, acestea trebuie folosite cu precauție extremă. Medicamentele numai progestative (fără estrogen) sunt benefice pentru unele simptome de menopauză și uneori pot avea un efect preventiv asupra simptomelor de AEE. Medicamentele non-hormonale au arătat, de asemenea, beneficii în gestionarea simptomelor menopauzei. Acestea includ inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) cum ar fi paroxetina sau citalopram, inhibitori ai recaptării serotoninei-norepinefrinei (SNRI) cum ar fi venlafaxina, desvenlafaxina, gabapentina, clonidina și oxibutinina. Din cauza numeroaselor opțiuni, este important să discutați în detaliu despre tratamentul simptomelor menopauzei cu echipa dumneavoastră de asistență medicală.

La ce mă pot aștepta dacă trebuie să fac o histerectomie?

Există două probleme primare specifice AEE care trebuie luate în considerare în cazul unei histerectomii. Primul este riscul ca procedura chirurgicală să declanșeze un atac de AEE, deoarece aceasta poate apărea în cazul traumatismelor

chirurgicale sau manipulării căilor respiratorii dacă se utilizează anestezie generală. Echipa de chirurgie și anestezie ar trebui să fie conștientă de diagnosticul de AEE și să aibă un plan de management al AEE în colaborare cu medicul dumneavoastră care tratează AEE. A doua problemă se referă la orice efecte hormonale pe termen lung ale intervenției chirurgicale. Aceasta depinde dacă ovarele sunt îndepărtate (ooforectomie) simultan cu uterul (histerectomie). Decizia de a elimina ovarele este importantă pentru a o discuta cu ginecologul/chirurgul, deoarece există riscuri și beneficii potențiale pentru sănătatea Dvs pe termen lung. Îndepărtarea ovarelor va provoca în esență menopauza prin reducerea producției de estrogen. Deși acest lucru poate influența simptomele de AEE, efectul clinic este imprevizibil și nesigur. Histerectomia/ooforectomia nu este recomandată în prezent ca abordare de tratament pentru AEE, iar aceste proceduri ar trebui efectuate numai din alte motive medicale.

Ar trebui să schimb/scad doza de C1-INH dacă simptomele scad în timpul menopauzei?

Ajustarea oricăror medicamente pentru AEE, inclusiv înlocuirea de C1-INH, trebuie discutată și făcută în colaborare cu medicul dumneavoastră care tratează AEE. Astfel de modificări se bazează în general pe evoluția clinică a simptomelor de AEE, pe factorii de calitate a vieții și pe potențialele efecte adverse ale medicamentului. Adesea, ajustările la tratament sunt importante în timpul diferitelor faze sau evenimente ale vieții, în special în cazul regimurilor profilactice pe termen lung. Menopauza este un moment în care simptomele de AEE se pot ameliora sau se pot agrava datorită influenței modificărilor hormonale, așa că poate fi foarte rezonabil să se ia în considerare ajustări ale planului de tratament. Asigurați-vă că discutați acest lucru cu medicul dumneavoastră care tratează AEE pentru a vă asigura că acest lucru se face cât mai sigur posibil.



HAEi
HAE International

Citiți mai multe pe haei.org · ianuarie 2024